

Obsesje i kompulsje

OCD to nie „wybór” ani „nadmierna staranność”. To zaburzenie neuropsychiczne dotyczące 2–3% populacji. Czwarte najczęstsze.

CZAS: 15–20 min czytania Pierwsza karta — fundament psychoedukacji

ŹRÓDŁO: Ruscio i wsp. (2010); Rachman i de Silva (1978); APA (2022, DSM-5-TR)

JAK UŻYWAĆ

Zrozum dwa podstawowe pojęcia: **obsesje** (natrętne, niechciane myśli wywołujące lęk) i **kompulsje** (powtarzalne zachowania redukujące lęk). Naucz się rozpoznawać **cykl podtrzymujący**: obsesja → lęk → kompulsja → ulga → wzmocnienie obsesji. Zrozum: **90% populacji ma podobne intruzje** — różnica polega na *reakcji*, nie na samej myśli.

DLACZEGO TO DZIAŁA

OCD (ang. *obsessive-compulsive disorder*) to zaburzenie neuropsychiczne charakteryzujące się obecnością obsesji i/lub kompulsji powodujących znaczący dyskomfort i upośledzenie funkcjonowania. Częstość: **2–3%** populacji w ciągu życia (Ruscio i wsp., 2010, *Mol Psychiatri*). To **czwarte** najczęstsze zaburzenie psychiczne. Kluczowe odkrycie: Rachman i de Silva (1978): **90% osób bez OCD** doświadcza intruzji o *tej samej treści* co osoby z OCD. Różnica leży w **interpretacji** tych myśli — i w reakcji na nie.

01 Dwa elementy OCD

OBSESJE

Natrętne, niechciane myśli, obrazy lub impulsy, które:

- pojawiają się *mimowolnie*
- wywołują silny dyskomfort, lęk, wstręt
- są oceniane jako *obce* tożsamości
- pacjent próbuje je **zignorować lub stłumić**

Przykłady: myśl o skażeniu, obraz krzywdzenia bliskich, impuls przeklinania w kościele.

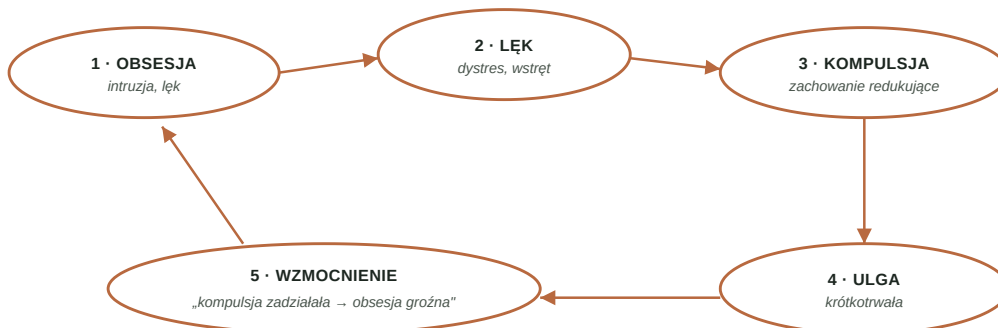
KOMPULSJE

Powtarzalne zachowania (zewnętrzne lub mentalne), które:

- mają zapobiec lub zredukować lęk
- są *szttywne* i rytualne
- **nie są realnie połączone** z zagrożeniem
- dają *krótkotrwałą* ulgę

Przykłady: mycie rąk 30 razy, sprawdzanie zamka 8 razy, powtarzanie „bezpiecznych” zdań w głowie.

02 Cykl podtrzymujący — pięć etapów



Paradoks OCD: kompulsja *wyduje się rozwiązaniem* — i krótkoterminowo działa (lęk opada). Ale **każda ulga uczy mózg:** „obsesja była realnym zagrożeniem, bo kompulsja je usunęła”. Im więcej kompulsji, tym silniejsze przekonanie, że są *niezbędne*. Pętla narasta przez lata.

03 ? Co to NIE jest OCD

NIE „LUBIĘ PORZĄDKU”

„Jestem trochę OCD, bo lubię uporządkowane biurko” — to **nie OCD**. OCD wymaga znaczącego dyskomfortu (≥ 1 h dziennie) i upośledzenia funkcjonowania.

NIE „DZIWNA MYŚL”

Pojedyncza intruzja u 90% populacji. OCD wymaga **nawracających** intruzji + interpretacji jako zagrożenia + kompulsji.

NIE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI

OCD $\neq$ OCPD (osobowość anankastyczna). W OCD obsesje są *egodystoniczne* (obce). W OCPD — sztywne wzorce *tożsamościowe*.

NIE PSYCHOZA

Pacjent z OCD **wie**, że obsesja jest „nielogiczna”. Ten dystans (*insight*) odróżnia OCD od urojeń.

04 ✎ Twój wstępny obraz — rozpoznanie

MOJE NAJCZĘSTSZE OBSESJE

— jakie myśli/obrazy/impulsy

MOJE NAJCZĘSTSZE KOMPULSJE

— co robię, by zredukować lęk

ILE CZASU DZIENNIE ZAJMUJĄ

— minut/godzin

CO PRZEZ NIE TRACĘ

— relacje, praca, sen, czas

Klucz: Rachman i de Silva (1978) — przełomowe odkrycie: **90% ludzi bez OCD** doświadcza takich samych intruzji jak osoby z OCD. *Różnica nie leży w myśli* — leży w tym, jak ją **oceniamy** i jak na nią reagujemy. Osoby bez OCD myślą „dziwna myśl, no cóż” i idą dalej. Osoby z OCD myślą „skoro pomyślałem o krzywdzeniu kogoś, to coś o mnie mówi” i uruchamiają kompulsje. To **nie wina ani charakter** — to wzorzec neuropsychologiczny, który można zmienić. Leczeniem pierwszej linii jest *terapia poznawczo-behawioralna z ERP* (NICE CG31, 2005).